

三型體質整合臨床培訓

PPT 1 (Deep v2)

九型三中心 × 理法方藥 × App 臨床落地

Eden TCM Clinic 醫師內訓

講者：[你的名字]

日期：[yyyy-mm-dd]

本講目標（加深版）

- 統一三型體質判讀語言與證據格式
- 把「三中心反應」穩定轉譯成中醫辨證方向
- 建立理法方藥決策節奏：守方、微調、轉法
- 把臨床判讀完整落到 App 追蹤

今日輸出：全體醫師用同一模板寫到「主型/次型 + 理法方藥 + 追蹤指標」。

為何必須統一框架

- 同症不同判：病人對診所專業感受不穩定
- 覆診難接手：第二位醫師難即時接續思路
- 方藥變動過大：療效與副反應難評估
- 教病人靠個人習慣：依從性波動大

問題核心不是技術不足，而是「流程與語言未標準化」。

框架總圖：四層一體

1. **三型體質**：先做第一層分流（主型 + 次型）
2. **三中心反應**：理解壓力下的反應風格（頭/心/腹）
3. **理法方藥**：病機到治法再到方藥加減
4. **App 記錄**：把每次診療變成可追蹤數據

四診為本，三中心為輔；人格工具幫理解，不作診斷標籤。

三型體質：臨床判讀矩陣（可替換你正式命名）

體質型	核心病機軸	常見主訴群	首治優先
[型A]	氣機鬱滯/神志易擾	失眠、焦慮、胃口波動	先調氣機與神志
[型B]	氣血失調/情志內耗	疲倦、情緒波動、經期紊亂	先復資源再調鬱
[型C]	升降失司/筋脈受阻	脹悶痛症、睡眠淺、反覆不舒	先通樞機再顧根本

你可把上表三列改為你文章中的正式三型名稱與定義句。

首診四步法（深版）

- 第一步：抓主訴軸（哪項最影響功能）
- 第二步：看三中心（病人壓力下第一反應）
- 第三步：以四診驗證（舌脈+問診證據）
- 第四步：下「主型/次型 + 理法方藥 + 指標」

三個必要問題（門診可直接問）

- 你最近最困擾、最影響生活的是哪一個症狀？
- 壓力上來時，你第一反應是擔心、討好，還是硬撐？
- 上一輪治療後，睡眠/食慾/二便哪一項最明顯變化？

三中心轉譯到中醫（核心對照）

三中心	反應模式	中醫觀察重點	治療切入
頭中心（5/6/7）	風險預期、過度思慮	神志、氣機、痰熱/鬱熱線索	安神調氣、清化鬱熱
心中心（2/3/4）	關係負荷、價值焦慮	情志與氣血互動、肝脾心軸	養血和中、疏肝解鬱
腹中心（8/9/1）	控制忍壓、憤/抑並見	升降失司、樞機不利、痛症傾向	和中通降、疏調臟腑

原則：反應風格決定問診深度，四診證據決定治療方向。

[型A] 深化：辨證與調方節奏

- 典型錯誤：把「焦慮」直接等同於純實火
- 正確做法：先分鬱、痰、虛，再決定清、宣、養比例
- 調方節奏：首診先穩睡眠與胃納；二診再處理餘證
- App 指標：入睡時間、夜醒次數、晨起疲倦、胃口分數

判斷提示：若夜醒減少但口乾仍在，未必急於大幅清降，先看舌脈與二便再定。

[型B] 深化：資源修復與疏調並行

- 典型錯誤：只攻鬱、不顧氣血，病人易更疲乏
- 正確做法：以功能恢復為先，再做情志層加減
- 調方節奏：先提升白天能量與食納，再校正情緒波幅
- App 指標：日間精神、經前/經後變化、心煩與胸悶頻率

判斷提示：情緒改善慢於體力恢復屬常見節奏，不代表方向錯誤。

[型C] 深化：升降樞機與慢性痛症

- 典型錯誤：只止痛，不處理升降失司根底
- 正確做法：先通中焦樞機，再按部位與時相微調
- 調方節奏：首診先降逆/通滯；二診再辨寒熱虛實偏向
- App 指標：痛分、脹滿分、排便質地、睡眠深度

判斷提示：痛分下降但脹滿未退，表示樞機未全開，宜守方向微調。

理法方藥決策：守方、微調、轉法

- **守方**：主症下降且副反應可接受
- **微調**：主症停滯、次症突出（單次只改關鍵幾味）
- **轉法**：方向錯配或新病機主導（有明確證據才轉）

覆診四問（固定）

- 主訴變化幾成？
- 睡眠/二便/食慾有何變化？
- 有沒有新不適或副反應？
- 病人任務完成率如何？

原則：每次調整都要「可追蹤、可比較、可回退」。

App 記錄：每次就診必填（升級版）

- 主訴與病程（以功能影響排序）
- 四診摘要（舌、脈、關鍵問診）
- 三中心反應（頭/心/腹，含觸發情境）
- 體質判定（主型/次型 + 依據）
- 理法方藥（為何加減，不寫空泛語句）
- 下次追蹤指標（3 個量化項）

建議欄位模板：主型：[] 次型：[] 依據：[]；本次目標：[]；下次評估：[]。

小病例示範（教學用）

個案摘要

- 主訴：失眠 3 月，伴胸悶、晨起乏力
- 三中心：頭中心為主（反覆預期壞結果）
- 四診：舌紅苔薄膩、脈弦細
- 判定：主型 [型A]，次型 [型B]

處理策略

- 理：鬱熱夾虛，神志不寧
- 法：先宣鬱寧神，兼顧中焦
- 方藥：以主方小幅加減，設定 2 週回訪
- 指標：入睡時長、夜醒次數、晨醒疲倦

常見誤判與團隊校準機制

- 誤判 1：把三中心等同人格診斷
- 誤判 2：每位醫師自建語言，跨人員不可比
- 誤判 3：追求「立即見效」，過度頻繁改方
- 誤判 4：未定追蹤指標，覆診只憑印象

校準建議（每週 30 分鐘）

- 共讀 2 份病歷（1 份順利、1 份卡關）
- 對齊主型/次型判定依據
- 記錄本週最易誤判點，下週先預防

延伸讀物：交錯讀法（給醫師內訓）

讀法原則：一經典 + 一臨床 + 一回寫

- 經典：聚焦「鬱」與「升降出入」原則
- 臨床：看現代醫家如何落地為可操作方案
- 回寫：每讀完一節，回到本院病例寫 200 字反思

建議節奏（4 週）

- 第 1-2 週：先把術語對齊（郁、火、熱、虛、實）
- 第 3 週：做病例對照（同症不同病機）
- 第 4 週：整合成診所版「理法方藥備忘卡」

《火鬱發之》一書簡介（內訓指定）

- 書名：《火鬱發之（第2版）》
- 作者：李士懋、田淑霄
- 出版：中國中醫藥出版社（2023/12）
- 特色：以臨床誤治反思切入，重建「火鬱」辨治路徑

為何值得交錯讀

- 提醒臨床：火鬱不是單一病名，而是跨科常見病機
- 強化判讀：避免把所有「熱象」都粗暴歸為實火
- 對接本框架：有助 [型A/B/C] 的鬱熱、夾虛、夾痰判別

閱讀任務：每位醫師從書中提 1 條「易誤治點」對照自己 1 例病案。

本講收束與本週任務

- 任務 1：每位醫師完成 1 例「主/次型 + 四診 + 指標」完整記錄
- 任務 2：共讀《火鬱發之》指定章節，提交 200 字臨床反思
- 任務 3：下次會議帶 1 例卡關個案做團隊校準

先統一語言，再統一流程；先穩定判讀，再放大療效。

資料註：本簡介之書籍資訊可對照博客來與三民網路書店頁面。